

Berlin, den 28.11.2024

Betrifft: Möller, Uwe , * 16.12.1986

HR Dr. Norbert Munz,

die Untersuchung ergab folgenden Befund:

Klinische Indikation: Z.n. Sturz auf das rechte Handgelenk am 26.11.2024. Erbitte CT des rechten Handgelenks bei V.a. Handwurzelfraktur.

Die rechtfertigende Indikation wurde gestellt.

CT Handgelenk rechts nativ vom 28.11.2024

Methodik: Aufklärung und Einverständnis. Native MS-Spiral-CT des rechten Handgelenks, hochauflösend, knöchern. MPR.

Befund: Es liegen keine Voruntersuchungen zum Vergleich vor.

Regelrechte Artikulationsverhältnisse im rechten Handgelenk, distalen Radioulnargelenk, intercarpal und carpometacarpal sowie metacarpophalangeal 1. Unauffällige Darstellung der Knochenmatrix. V.a. intraartikulären Erguss im Bereich der Carpalia. Flau abgrenzbare hypodense Linie mit Unterbrechung der Corticalis an der distalen Basis des Hamulus ossis hamati, querverlaufend und scheinbar schräg nach palmar an den unteren Rand des Hamulus ossis hamati ausstrahlend (Se 2/IMA ± 135 ; Se 40991/IMA ± 53). Darüber hinaus kein Nachweis kortikaler Unterbrechungen. Kein Nachweis dislozierter Fragmente. Kompaktinsel im Os hamatum angrenzend an das Carpometacarpalgelenk V. Geringe osteophytäre Randanbauten radioscapoidal streckseitig und lateral mit initialer subchondraler Mehrsklerosierung. Z.n. Plattenosteosynthese des Os metacarpale IV wohl bei Z.n. Fraktur, kein einsehbarer Frakturspalt, Konsolidierung in geringer Fehlstellung.

Beurteilung:

- V.a. nicht dislozierte Fraktur des Hamulus ossis hamati rechts und intraartikulären Erguss.
- Z.n. plattenosteosynthetisch versorgter Fraktur des Os metacarpale IV rechts mit vollständiger knöcherner Durchbauung bei Konsolidierung in geringer Fehlstellung.
- Geringe streckseitig-laterale Radioscapoidalarthrose.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen